INTUBATION DIFFICILE EN APNÉE AU BLOC OPÉRATOIRE

CONFIRMER l'intubation difficile :

- ❑ Échec d'intubation au vidéolaryngoscope (3 tentatives maximum, maintien d'une SpO_2 > 95%)
- ❑ Malgré l'optimisation de l'intubation :
  - ❑ Curarisation
  - ❑ Mobilisation laryngée externe
  - ❑ Optimisation de la position de la tête
  - ❑ Utilisation d'un mandrin
  - ❑ Changement de lame / de vidéolaryngoscope
  - ❑ Changement d'opérateur

APPEL À L'AIDE

Tel renfort MAR = ...

Tel chir / ORL = ...

PRIORITÉ = MAINTENIR L'OXYGÉNATION

Si **DÉSATURATION** durant la procédure :

- ❑ Optimiser la ventilation au masque facial :
  - ❑ Curarisation / Approfondissement sédation
  - ❑ Canule de Guedel / Ventilation à 4 mains
  - ❑ Changement d'opérateur

↓ ÉCHEC

- ❑ Utiliser dispositif supra-glottique (DSG) de 2ème génération :
  - ❑ 3 tentatives maximum
  - ❑ Contrôle courbe de capnographie
  - ❑ Anticiper cricothyroïdotomie

↓ ÉCHEC

Si **DÉSATURATION** persistante :

- ❑ Cricothyroïdotomie (cf verso) :
  - ❑ Technique SMS en 1ère intention
    - Extension cervicale
    - FiO_2 100% à travers le DSG
    - Echorepérage (si possible)

↓ Après correction de la SpO_2

- ❑ Pause / Réflexion :
  - ❑ Réveil / Report de la chirurgie
  - ❑ Chirurgie (si urgente)
  - ❑ Trachéotomie secondaire

↓ SUCCÈS

Après correction de la SpO_2 :

- ❑ Pause / Réflexion :
  - ❑ Poursuite de la chirurgie avec le DSG
  - ❑ Intubation fibro-guidée à travers le DSG
  - ❑ Réveil / Report de la chirurgie

→

Succès de l'intubation / du DSG =

- ❑ **Courbe de capnographie ($EtCO_2$)**
- ❑ Correction de la SpO_2

APRÈS L'INTERVENTION

- ❑ Si extubation à risque : rester vigilant, adapter les moyens humains et matériels
- ❑ Remettre un certificat d'intubation difficile au patient (cf modèle certificat SFAR)
- ❑ Débriefing en équipe

Références : RFE SFAR 2026 "Prise en charge initiale des voies aériennes de l'adulte au bloc opératoire"

Réalisée en 2016 et mise à jour en 2026 par le CAMR